

# 国家卫生健康委员会

## 特殊人群健康服务司

国卫人发〔2020〕36号

# 体内银离子异常综合征人员 社区服务培训手册

（地级市版·第三版）

适用：各设区的市（地级市）卫生健康部门及其管理指导的县（市、区）有关人员

编制：国家卫生健康委员会特殊人群健康服务司

印发：2020年6月

密级：内部资料·注意保存

## 编制说明

为规范地级市层面特殊人群健康服务工作，统一基层报告、核查、告知与服务流程，依据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国精神卫生法》有关精神和国家卫生健康委员会关于特殊人群健康服务工作的部署要求，结合各地试点经验，编制本手册。

本手册按 2004 年以来实行的传染病直报机制与网格化管理经验编写，供地级市及以下承担特殊人群健康服务职能的工作人员培训使用。本手册为内部资料，不对外发放。

## 目 录

培训总览

第一章 职责与分级管理

第二章 病例发现与上报

第三章 初次核查

第四章 登记建档

第五章 知情告知

第六章 分级服务

第七章 重大事项与婚育服务

第八章 应急处置

第九章 信息管理与数据质量控制

第十章 绩效评价与考核

第十一章 纪律与责任

第十二章 典型情景与考核

附则

附件 表式

## 培训总览

### 一、培训目标

1. 掌握病例的发现渠道与直报流程，知道哪些信息必须直接上报地级市部门、哪些信息不得写入常规报告；
2. 能够按规范完成初次核查与知情告知，会处理“中邪”“闹鬼”等民间说法；
3. 熟悉分级服务要求，懂得第三级及以上人员的非接触原则；
4. 掌握台账、保密、信息管理、应急处置和报表的基本要求。

### 二、课时与考核

1. 集中培训不少于 24 学时；
2. 培训结束后进行笔试与情景考核，合格方可上岗；
3. 每两年复训一次。

### 三、适用对象

1. 地级市特殊人群健康服务部门负责人及服务专员；
2. 县（市、区）卫生健康部门专职岗位人员；
3. 参与非知情配合的乡（镇、街道）卫生机构有关人员（仅限职责范围内内容）。

## 第一章 职责与分级管理

### 一、管理层级

本项工作实行属地管理，管理重心设在地级市：

1. 地级市卫生健康部门设特殊人群健康服务处（科），负责本辖区管理、台账、核查、告知的组织与审核；
2. 县（市、区）卫生健康部门设专职岗位，承担具体执行；
3. 乡（镇、街道）卫生机构及村（居）委会、社区网格员承担非知情配合；
4. 台账与敏感信息不留在基层。

### 二、岗位与条件

1. 负责人：组织协调、审核把关；
2. 服务专员：线索核查、知情告知、登记建档、日常随访；
3. 复核人：抽查复核服务质量；

4. 服务专员须经培训考核合格并签订保密承诺书；涉及异性服务对象时原则上安排同性专员或两名同行。

【提示】基层网格员、村（居）委会人员不了解本项工作，仅在核查或补给确认时予以非知情配合，不掌握任何信息。

## 第二章 病例发现与上报

### 一、发现渠道

本项工作依托现有信息系统中的特殊标记模块，实现“发现即上报、不进入常规报告”：

1. 血液检验发现：因体检、住院、献血、术前检查等原因进行血液检验时，检出银离子异常的，由检验系统直接上报特殊系统，不写入常规检验报告，本人不知情；
2. 公安机关特殊标记：公安治安、刑侦系统录入符合特定特征的事件时，由系统自动加注特殊标记并直接推送；该标记不进入常规警情统计；
3. 其他检验场景：血液中心、职业健康体检、司法鉴定等机构检出银离子异常的，按第一项同程序上报；
4. 说明：本项工作不设公开服务窗口、不对外宣传；本人一般不知情，不存在“主动咨询”渠道。

### 二、上报流程

1. 特殊系统自动比对并推送线索至地级市特殊人群健康服务部门；
2. 地级市部门于收到线索后两个工作日内安排核查；
3. 紧急线索立即处置；
4. 所有线索登记入账，登记内容包括来源、时间地点、初步特征、报告人及联系方式。

### 三、线索分级

1. 一般线索：特征不明显，需进一步核实；
2. 紧急线索：出现可能危及本人或他人安全情形的，立即启动应急处置。

【提示】特殊系统推送的线索，只由地级市部门掌握；县、乡镇、村不再留存线索信息。

## 第三章 初次核查

## 一、基本要求

1. 初次核查由地级市部门统一安排，原则上两名专员同行；
2. 核查以非侵入方式进行，不强制采血、不查看无关信息；
3. 核查目的在“确认与告知”，不在“调查取证”。

## 二、核查步骤（勾选清单）

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 1. 两名专员到位，携带工作证与文书；</li><li><input type="checkbox"/> 2. 表明身份，说明来意；</li><li><input type="checkbox"/> 3. 在本人自愿前提下了解基本生理情况；</li><li><input type="checkbox"/> 4. 作知情告知（见第五章）；</li><li><input type="checkbox"/> 5. 介绍国家可免费提供的服务；</li><li><input type="checkbox"/> 6. 记录本人意见与反应；</li><li><input type="checkbox"/> 7. 经同意后建立联系；本人拒绝的，尊重其选择。</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

【提示】本人情绪激动时，暂停告知，改日再访；不得强行完成告知。

## 第四章 登记建档

### 一、台账要求

1. 台账由地级市部门统一建立，编号格式为“市代码—年度—序号”；
2. 台账信息录入专用离线系统，与一般卫生信息系统分离；
3. 纸质档案存放于地级市部门专柜，钥匙专人保管，查阅登记。

### 二、信息分级

1. 第一、二级服务对象的台账由地级市掌握；
2. 第三级及以上人员的领地方位坐标由地级市部门掌握并报省级备案，访问权限限于部门负责人及两名指定副职。

## 第五章 知情告知

### 一、告知内容

1. 血液中银离子为非病理浓度存在，与其本人无涉；
2. 情绪与身体状况存在已知关联，属可管理范围；
3. 国家可免费提供生理指标跟踪、情绪管理、社会身份辅导和就业支持；
4. 是否接受服务由本人自愿决定。

### 二、告知语言

告知使用通俗医学语言，不使用“遗弃”“净化”“宿主”“女巫”等词汇。群众中“中邪”“撞邪”“闹鬼”“附体”“着魔”等说法，系民间旧称；专员不予附和、不作神秘解释，以平和语气说明“这是可以管理的身体状况”。

### 三、同意与拒绝

1. 同意者签署知情同意书，一式两份；
2. 拒绝者签署自愿不参与追访声明，此后不再主动联系；
3. 仅当生理指标显著异常并可能危及公共安全时，由地级市部门逐级评估。

【提示】发现因民间说法导致服务对象被歧视、排斥或伤害的，及时报告并联系村（居）委会、民政等部门妥善处理。

## 第六章 分级服务

### 一、第一级

以社区融入为主，提供生理指标跟踪、情绪管理指导、社会身份辅导、就业支持，由本人自愿选择。

### 二、第二级

提供稳定社会身份嵌入（社区服务岗位、乡镇卫生院岗位、图书馆等），可选择不开居住信息，由上级专员定期非接触随访。

### 三、第三级及以上

实行非接触管理。依托村（居）委会及周边群众，通过观察指定位置基本生活补给是否被取走等非接触方式确认其基本状况；不接近、不标记、不询问。每年在领地边缘以外指定位置放置基本生活补给，不附文字。确需技术核实的，由省级卫生部门统筹安排，地级市部门不得自行采取技术手段。

## 第七章 重大事项与婚育服务

### 一、婚姻与婚前医学检查

服务对象办理婚姻登记前，可参照《母婴保健法》关于婚前医学检查的规定，由本人自愿接受婚前检查。是否向配偶告知，由服务对象本人决定；经本人同意，由专员、服务对象及其配偶在场告知，告知内容限于已知医学事实，不使用任何敏感表述。告知情况记入台账，配偶签署知情确认书。

### 二、就业、升学、住院

按类似程序办理；涉及医疗机构时，可提供经脱敏处理的健康状况说明。

## 第八章 应急处置

### 一、应急情形

1. 服务对象出现可能危及本人或他人安全的情形；
2. 第三级及以上人员活动范围出现异常变化；
3. 因民间说法引发群体性事件。

### 二、处置程序

1. 立即报告地级市部门负责人；
2. 评估情形，必要时联系公安、民政、村（居）委会协同；
3. 不自行采取强制措施；
4. 事后 24 小时内形成书面报告。

## 第九章 信息管理与数据质量控制

### 一、信息管理

1. 台账与报告信息统一由地级市部门归口管理；
2. 数据录入做到及时、准确、完整，不得虚报、瞒报、漏报；
3. 定期对数据进行核对和清理，发现问题及时更正。

### 二、数据安全

1. 信息系统访问实行权限管理，非授权人员不得登录；
2. 数据传输、存储按保密要求执行；
3. 不得在非涉密设备、非授权场合处理服务对象信息。

## 第十章 绩效评价与考核

### 一、绩效评价

1. 地级市部门每年对县（市、区）开展一次工作检查；
2. 评价内容包括：线索处置及时率、告知完成率、台账质量、保密执行、报表及时性；
3. 评价结果作为拨付工作经费和人员绩效的参考。

### 二、考核方式

1. 笔试：考手册内容；
2. 情景考核：模拟初次核查、告知、应急处置等场景；
3. 考核不合格的，须补训后重新考核。

## 第十一章 纪律与责任

1. 违反保密规定的，依有关规定处理；造成严重后果的，依法追究责任；
2. 擅自将服务对象信息向无关人员、单位、媒体披露的，从重处理；
3. 擅自扩大知悉范围的，依纪依规处理；
4. 工作人员因职务知悉的信息，离职后仍负有保密义务。

## 第十二章 典型情景与考核

### 情景一 本人拒绝服务

处置：尊重决定，提供自愿不参与追访声明；不作反复劝说不。记录于台账。

### 情景二 家属说“这是中邪”

处置：不附和、不反驳；以平和语气说明是可管理的身体状况；发现歧视或伤害及时报告。

### 情景三 本人即将结婚

处置：按第七章婚前医学检查与告知程序办理；未经本人同意不得告知配偶。

### 情景四 第三级人员未取走补给

处置：记录并报告地级市部门；不接近；由部门评估后续安排。

### 考核自测（节选）

1. 特殊系统的线索由哪一级部门掌握？（ ）  
A. 乡镇卫生院 B. 地级市部门 C. 村（居）委会 D. 网格员
2. 医院检验检出银离子异常，应如何报告？（ ）  
A. 写入常规报告 B. 由系统直接上报特殊系统 C. 电话口头报告 D. 不报告
3. 对第三级人员应采取哪种方式？（ ）  
A. 上门随访 B. 卫星监测 C. 非接触、不接近 D. 强制收治
4. 家属说“中邪”，正确的做法是？（ ）  
A. 附和 B. 用医学语言解释 C. 请道士 D. 不予回应并离开
5. 向配偶告知的条件是？（ ）  
A. 随时可告知 B. 经本人同意 C. 由家属决定 D. 不可告知

## 附 则



1. 本手册自印发之日起施行；
2. 本手册由特殊人群健康服务司负责解释；
3. 各地可结合实际制定实施细则，报特殊人群健康服务司备案。

## 附件 表式

### 附件一 初次核查记录表

编号：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日  
线索来源：☐检验系统 ☐公安标记 ☐基层机构检验 ☐其他  
所在县（市、区）：\_\_\_\_\_  
告知完成：☐是 ☐改期 本人意见：☐同意 ☐拒绝 ☐未定  
专员：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

### 附件二 知情告知记录表

编号：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日  
告知内容：☐银离子说明 ☐情绪与体况关联 ☐服务介绍  
本人提问及答复：\_\_\_\_\_  
本人意见：☐同意 ☐拒绝 ☐需考虑  
本人签字：\_\_\_\_\_ 专员：\_\_\_\_\_

### 附件三 自愿不参与随访声明

本人已知晓告知内容，自愿不参与后续健康随访与服务。本人知悉：如生理指标显著异常并可能危及公共安全，有关部门将依法采取必要措施。  
声明人：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### 附件四 保密承诺书

本人承诺对服务对象信息严格保密，不得以任何形式泄露，离职后仍承担保密义务。  
承诺人：\_\_\_\_\_ 单位：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### 附件五 配偶知情确认书

本人为服务对象（编号\_\_\_\_\_）之配偶，已于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日知悉其身体状况之已知医学事实及可提供服务，无异议。  
确认人：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### 附件六 季度工作统计表

地级市：\_\_\_\_\_ 季度：\_\_\_\_年第\_\_季度  
在册人数：\_\_\_\_ 新增：\_\_\_\_  
第一级：\_\_\_\_ 第二级：\_\_\_\_ 第三级及以上：\_\_\_\_  
告知完成：\_\_\_\_ 拒绝随访：\_\_\_\_  
填报人：\_\_\_\_\_ 审核人：\_\_\_\_\_

内部资料·注意保存

—— 本手册由特殊人群健康服务司负责解释 ——

内部资料·注意保存·不对外发放

2020 年 6 月